



MÓDULO: QUESTÕES – POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA
PROFESSORA: MICHELLE SAMPAIO

1. (Ano: 2022 Banca: CONSULPAM Órgão: Prefeitura de Irauçuba – CE) Constitui o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o sistema de atenção à saúde, trazendo os serviços de saúde para mais próximo dos lugares de vida e trabalho das pessoas, e constitui-se como o primeiro elemento de um processo contínuo de atenção. O conceito acima refere-se à definição de:

- A) Rede de Gestão da Saúde.
- B) Sistema Integrado de Saúde.
- C) Coordenação Especial de Saúde.
- D) Atenção Primária à Saúde.

2. (Ano: 2022 Banca: OBJETIVA Órgão: Prefeitura de Alecrim – RS) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, é uma diretriz do SUS e das Redes de Atenção à Saúde a ser operacionalizada na Atenção Básica:

- A) Equidade.
- B) Universalidade.
- C) Territorialização.
- D) Descentralização do cuidado.

3. (Ano: 2018 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Vila Velha – ES) A Política Nacional da Atenção Básica recomenda uma população adscrita por equipe de Atenção Básica e de Saúde da Família de quantas pessoas?

- A) 500 a 1.000
- B) 1.500 a 2.500
- C) 2.000 a 3.500
- D) 3.000 a 4.000
- E) 4.000 a 5.000

4. (Ano: 2022 Banca: CONSULPAM Órgão: Prefeitura de Irauçuba – CE) Sobre as Equipes de Saúde da Família (ESFs), assinale a alternativa CORRETA:

A) Deve ser composta no mínimo por: médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem.

B) Para equipe de Saúde da Família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da ESF. Dessa forma, os



profissionais da ESF poderão estar vinculados a mais de 1 (uma) equipe de Saúde da Família, no SCNES vigente.

C) O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local.

D) Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com número máximo de 950 pessoas por ACS.

5. (Ano: 2017 Banca: FEPESE Órgão: Prefeitura de Fraiburgo – SC) Em relação às atribuições específicas dos agentes comunitários de saúde descritas na Política Nacional de Atenção Básica, é correto afirmar:

A) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.

B) Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local.

C) Definir o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos.

D) Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e a avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis.

E) Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis nos prontuários.

6. (Ano: 2021 Banca: FAUEL Órgão: Prefeitura de Catanduvas – PR) Conforme descrito na Política Nacional de Atenção Básica, no Capítulo I, Das disposições gerais da Atenção Básica de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA acerca da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS).

A) Cada ACS deve realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 450 pessoas.

B) A atividade do ACS deve se dar pela lógica do planejamento do processo de trabalho a partir das necessidades do território, com priorização para população com maior grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico.

C) A atuação em ações básicas de saúde deve visar à integralidade do cuidado no território.

D) Cadastrar, preencher e informar os dados através do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica vigente.

7. (Ano: 2019 Banca: CONSULPAM Órgão: Prefeitura de Resende – RJ) De acordo com a Portaria Nº 2.488/GM de 2011, a Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica, devendo seguir as diretrizes da atenção básica e do SUS, prevendo como fundamentos e diretrizes, EXCETO:



A) Apoiar a articulação de instituições, em parceria com as Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, para capacitação e garantia de educação permanente para os profissionais de saúde da Atenção Básica.

B) Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.

C) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território sempre em consonância com o princípio da equidade.

D) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.

8. (Ano: 2022 Banca: CONSULPAM Órgão: Prefeitura de Irauçuba – CE) A Portaria n.º 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esta, leia e analise os itens a seguir:

I- É responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal.

II- É responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal analisar os dados de interesse estadual, gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.

III- É responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da população.

De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa CORRETA.

A) Apenas a alternativa I está correta.

B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.

C) Apenas as alternativas I e III estão corretas.

D) Apenas a alternativa III está correta.

GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8
D	C	C	C	A	A	A	C